

· 论 著 ·

老年人药物相互作用的药效学、药代动力学的门诊处方调查分析

张晓东

(河南中医学院第一附属医院 河南郑州 450000)

【摘要】 目的 观察、分析老年人药物之间存在的相互作用。方法 选取本院65岁以上老年人的门诊处方2561张,其中中成药516张,西药2045张,对其中的药物相互作用进行分析和总结。结果 和药物相互作用的药效学和药代动力学有关的门诊处方有78份。结论 目前的门诊处方中还存在老年人药物相互作用的药效学和药代动力学的情况,要引起药师和临床医生的重视。

【关键词】 老年人药物 药效学 药代动力学 门诊处方

【中图分类号】 R969.2

【文献标识码】 B

【文章编号】 1672-2523(2012) 02-0509-01

由于中国人口已经进入老龄化阶段,很多种疾病的产生都是伴随年龄的增大而日益严重,人老病就多,特别是一些慢性疾病。所以,一个老年人同时服用多种治疗药物的情况非常普遍,通常有慢性病的就用3到4种药物,10余种的时候也有出现[1]。但不是病多服药多就能解决问题,因为如果多种药物同时服用,就会因为它们之间的药物相互作用而严重影响治疗的效果,还会出现药物之间相互作用产生的副作用。所以,对老年人进行治疗时,药物的搭配和需要注意的事项就比较多。用药要有合理性,否则就会适得其反。

为了解我院门诊处方的老年用药情况,本文对我院的老年人用药处方进行药物相互作用的情况进行分析,从药效学和药代动力学的视角进行了一定的探讨。现报告如下:

1 材料与方法

1.1 临床资料 选取2010年1月到2010年5月本院65岁以上老年人的门诊处方2561张,其中中成药516张,西药2045张,共计患者2415例。

1.2 方法 对其中涉及到药物相互作用不合理的药物搭配进行记录、总结。

2 结果

研究、总结发现存在78种涉及到药效学或者药代动力学的药物作用搭配方案,其中涉及到中成药之间的药物相互作用、中西药之间的药物相互作用、西药之间的药物相互作用。主要不合理药物搭配情况详见表一。

3 讨论

因为年纪的原因,老年人对药物的代谢能力发生了减退以及障碍,身体对药物的耐受程度比较差,很容易发生药物的蓄积,而引起一系列的不良反应[2]。所以就要求医生在临床诊治中要更耐心的询问老年患者平时使用的药物,和药物过敏史等基本资料,医生也要积极的通过自身学习掌握临床常见的药物中间的相互作用会引起的不良反应,对待老年患者更要注意用药搭配和用药剂量,尽可能使用单种药和最小剂量[3],因为老年人的肝肾功能已经明显下降,代谢能力比较差,靶器官和靶细胞的敏感度比较强,特别是一些心脑血管、中枢系统治疗药物,在同样的正常剂量要比年轻人所反映的不良反映增强,严重的可以产生一些药源性的疾病。对一些有慢性疾病如高血压、糖尿病、风湿的老年人的常用药物要十分了解,对与这些药物有不良相互作用的感冒药、消炎

药、腹泻药等多发病要在使用时尽量避免,尽量选择一些安全性更好,没有相互作用的常用药物来替代治疗[4]。

根据世界卫生组织的调查,发现目前全球每年有三分之一的病人因为不合理用药而导致死亡,而不是因为患者所患疾病的本身。根据调查表明,我国的不合理开具处方和临床用药不合理的情况也十分严重,大约占所用临床处方的12%—32%。目前全国每年一共有大约5000多万的住院患者,可以计算至少有250万的患者应为药物的不合理应用而延误、加重病情,导致死亡的人数多达19万左右,大约平均每天就会因此死亡大约520例患者。在临床用药中,很多患者和医生都有这样的心态,即几种药物联合使用,效果会更好,总会有起到效果的,但事实上,不合理的联合用药已经出现很多问题,特别在老年患者的治疗方面,可能会产生预想不到的副作用。例如,有些药物之间会存在配伍的禁忌,如果联合使用会引起药物之间发生相互的作用,会导致药物本身降低疗效和失去疗效,严重是甚至会产生毒性反应等。同时,联合使用的药物种类越多,它们之间所产生的相互作用和引起不良反应的几率就会越大,所以,要求临床医生在联合用药时一定要注意药物搭配,必要时咨询医院执业药师。

本文通过研究、总结发现存在78种涉及到药效学或者药代动力学的药物作用搭配方案,此结果反映出目前本院的临床门诊处方中还存在一些非常严重的问题,尤其在老年人用药的药物相互作用方面还存在药效学和药代动力学的情况,所以,要引起药师和临床医生的高度重视。

参考文献

- [1] 张向明,老年门诊病人处方用药调查分析[J],浙江临床医学,2009,11(1) 111—112.
- [2] 张碧珍,段蓉,老年人药物相互作用的药效学、药代动力学分析[J],中国老年保健医学杂志,2009,7(2) 39—40.
- [3] 倪晓莉,我院门诊处方调查分析[J],中国医院用药评价与分析,2008,8(9) 711—713.
- [4] 刘学理,门诊处方不合理用药分析[J],中国医院药学杂志,2005,25(11) 1059—1059.

表1 处方中的不合理的药物搭配情况

药物搭配类型	具体药物	搭配药物	类属	简要陈述
中成药之间	大活络丹	蜜炼川贝枇杷露	药效学	产生毒性反应
中成药之间	复方丹参滴丸	速效救心丸	药代动力学	毒性药物重复
中成药之间	牛黄上清胶囊	附子理中丸	药效学	产生拮抗作用
西药之间	硝苯地平	银杏叶片	药代动力学	影响药物代谢
西药之间	阿司匹林	银杏叶片	药效学	产生拮抗作用
西药之间	阿司匹林	氢氯吡格雷	药效学	产生拮抗作用
西药之间	克拉霉素	多潘立酮	药代动力学	影响药物效果
中西药之间	牛黄上清胶囊	利福平	药代动力学	药物吸收降低
中西药之间	石膏	四环素	药物代谢药理学	影响药物分布